Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych

Nazwa wskaźnika	**'3.4.a Wydatki bieżące publiczne na ochronę zdrowia, jako % PKB '**
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Priorytet	Poprawa poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta, w tym rozwój obszaru e-zdrowie
Definicja wskaźnika	Udział wydatków bieżących publicznych na ochronę zdrowia w PKB.
Jednostka prezentacji	procent [%]
Dostępne wymiary	ogółem, rodzaj wydatków (wg podejścia funkcjonalnego)
Wyjaśnienia metodologiczne	Dane pochodzą z badania pn. **Narodowy Rachunek Zdrowia (NRZ)**, którego celem jest zestawienie wydatków na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według Międzynarodowej Klasyfikacji Rachunków Zdrowia (International Classification for Health Accounts - ICHA). Zakresem podmiotowym badania NRZ są schematy wydatków publicznych/obowiązkowych i prywatnych/nieobowiązkowych na ochronę zdrowia, zaś przedmiotowym - wydatki bieżące na ochronę zdrowia) zestawione zgodnie z ICHA (HP - dostawców, HF - schematów finansowania i HC - klasyfikacji funkcjonalnej świadczonych usług zdrowotnych) i we wzajemnych powiązaniach: HCxHF, HPxHF, HCxHP. Kwota wydatków uwzględnianych w NRZ, zgodnie z obowiązującą metodologią, obejmuje wydatki bieżące, a więc nie uwzględnia wydatków kapitałowych, do których zalicza się np. wydatki inwestycyjne, na badania i rozwój, kształcenie. Źródłem informacji do NRZ w zakresie wydatków publicznych (HF.1), na które składają się schematy rządowe, schematy obowiązkowych - składkowych ubezpieczeń, są m.in. systemy administracyjne instytucji, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia (tj. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Wykorzystywane są również wyniki innych badań realizowanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej i inne dostępne źródła informacji, służące głównie do oszacowania wydatków prywatnych. Na podstawie klasyfikacji funkcji ochrony zdrowia (ICHA-HC) wyróżniono dwa rodzaje wydatków: wydatki na usługi indywidualne i wydatki na usługi zbiorowe. Jako **usługi indywidualne** zaklasyfikowano produkty i usługi medyczne wykorzystywane bezpośrednio przez osoby indywidualne w zależności od ich potrzeb, należące według podejścia funkcjonalnego do kategorii: usługi lecznicze (HC.1), usługi rehabilitacyjne (HC.2), długoterminowa opieka zdrowotna (HC.3), pomocnicze usługi opieki zdrowotnej (nie określone przez funkcje) (HC.4) i artykuły medyczne (HC.5). Jako **usługi zbiorowe** zaklasyfikowano usługi odnoszące się do wszystkich grup populacji, należące według podejścia funkcjonalnego do kategorii: profilaktyka i zdrowie publiczne (HC.6) i zarządzenie i administracja finansowania ochrony zdrowia (HC.7).
Źródło danych	Główny Urząd Statystyczny
Częstotliwość i dostępność danych	Dane roczne; od 2013 r.

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych

Uwagi	Ze względu na specyfikę metodologii SHA2011 (A System of Health Accounts 2011) dane są przekazywane z dwuletnim opóźnieniem.
Data aktualizacji danych	10-03-2026
Data aktualizacji metadanych	26-04-2023